

Додаток
до листа ДУ «Центр громадського
здоров'я МОЗ України»
від 02.05.2025 № 04-12/18/2775/25

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
щодо розрахунків індикаторів якості медичної допомоги згідно
стандарту «Рациональне застосування антибактеріальних і
антифунгальних препаратів з лікувальною та
профілактичною метою» у 2024 році

Вступ

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до безпрецедентної еміграції, в тому числі медичних фахівців, руйнування закладів охорони здоров'я (далі – ЗОЗ), погіршенню санітарно-гігієнічних умов, економічним збиткам. Велика кількість поранених через бойові дії потребують лікування та профілактики інфекцій, а, отже, використання антибіотиків. Критичні навантаження на медичну систему загострили наявну проблему нераціонального споживання антимікробних препаратів (далі – АМП) та поширення антимікробної резистентності (далі – АМР) в Україні, що зумовлює підвищену актуальність моніторингу за споживання АМП та поширенням АМР.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2024 р. № 1265-р схвалено Державну стратегію боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів на період до 2030 року (далі – Стратегія). Загальні вимоги до проведення антибактеріальної терапії в закладах охорони здоров'я (далі – ЗОЗ), що передбачають раціональне використання АМП, попередження і зниження поширеності мікроорганізмів з АМР, встановлює стандарт медичної допомоги «Рациональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 серпня 2023 року № 1513 (далі – Стандарт). Розділ VII Стандарту передбачає моніторинг дотримання окремих положень шляхом розрахунку індикаторів якості медичної допомоги. **Відповідно до Стратегії передбачено моніторинг дотримання стратегічних цілей, серед яких є деякі вищезгадані індикатори якості медичної допомоги, а саме рівень призначення антибіотиків доступу, резерву та своєчасність бактеріологічних досліджень.**

Індикатори якості відображають розподіл споживання АМП різних груп згідно з класифікацією AWaRe адаптованною до системи охорони здоров'я в Україні (Ua AWaRe) та своєчасність проведення мікробіологічного дослідження.

I-III індикатори характеризують раціональність використання антибактеріальних препаратів у ЗОЗ, що надають первину та спеціалізовану медичну допомогу. Так, лікарям необхідно надавати перевагу призначенням антибактеріальних препаратів групи доступу, як антибіотиків з меншим потенціалом до поширення АМР, менш кошовних та з вузьким спектром дії. Антибактеріальні препарати групи спостереження використовують при неефективності антибіотиків групи доступу, а антибіотики групи резерву використовують у виняткових випадках у разі неефективності інших груп та при наявності добре обґрунтованих показань. **IV індикатор** характеризує організаційний аспект впровадження профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу. В таких ЗОЗ у всіх випадках призначення емпіричної антибіотикотерапії необхідно отримати зразок біологічного матеріалу для проведення бактеріологічного дослідження з метою ідентифікації збудника інфекційної хвороби до введення антибактеріального препарату пацієнтові.

Центри з контролю та профілактики хвороб МОЗ України (далі – ЦКПХ) збирають дані у ЗОЗ відповідної адміністративно-територіальної одиниці та проводять розрахунки індикаторів, які надалі передають до ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» (далі – Центр).

Від ЦКПХ отримано результати розрахунків у ЗОЗ, щодо яких було заплановано моніторинг у 2024 році. Далі наведено аналіз та обговорення отриманих даних.

Аналіз отриманих даних

Рівень споживання АМП групи доступу у ЗОЗ первинної ланки був меншим за цільові значення Стандарту, що зумовлено підвищеним рівнем споживання АМП групи спостереження та, що більш критично, АМП резерву (**таб. 1**). Галузеві стандарти, окрім окремих виключень, не передбачають використання АМП групи резерву на амбулаторному рівні, а процедура оптимізації їх використання фактично неможлива, так як програма адміністрування антимікробних препаратів нормативно не визначена на первинці. Великий розрив між цільовими значеннями індикаторів та фактичним значенням для ЗОЗ первинної ланки, вказує на нижчий рівень дотримання принципів раціонального використання АМП ніж у ЗОЗ спеціалізованого рівня.

У ЗОЗ що надають спеціалізовану допомогу рівень споживання АМП групи доступу був очікувано менше ніж на первинці, що обґрунтовано для допомоги на цьому рівні, але при тому був нижче цільових значень.

Було виявлено надзвичайно великий рівень споживання АМП резерву. Останнє, ймовірно, зумовлено великим рівнем споживання цефтриаксону та левофлоксацину – найбільш вживаних парентеральних АМП в Україні, що наказом МОЗ були перенесені до групи резерву (Ua AWaRe) через великий рівень поширення АМР та надлишкове споживання.

**Таблиця 1. Середнє значення індикаторів якості медичної допомоги
Стандарту розрахованих за 2024 р.**

Рівень надання допомоги, період	Кількість ЗОЗ	Пацієнти, яким призначено АМП групи доступу, %	Пацієнти, яким призначено АМП групи спостереження, %	Пацієнти, яким призначено АМП групи резерву, %	Пацієнти, яким АМП призначено після забору біологічного матеріалу для бактеріологічного дослідження, %
Первинна	350	59,1	32,4	8,7	н/а
Цільове значення Стандарту		95	<5	0	н/а
Спеціалізована	453	39,8	31,1	29,0	24,3
Цільове значення Стандарту		>60	<40	<5	100
Загальний підсумок (П+С)	803	48,2	31,6	20,2	24,3
Цільове значення Стратегії на 2024 рік		-	н/а	5	60

н/а – не передбачено визначення

Продовження їх використання у значних обсягах знижує ефективність боротьби з поширенням АМР до цих АМП при зниженій ефективності від їх емпіричного використання, особливо щодо нозокоміальних збудників.

Велике занепокоєння викликає дуже низький відсоток своєчасно виконаних бактеріальних досліджень, що в 4 разів нижче цільового значення Стандарту та більш ніж вдвічі менше передбаченого Стратегією у 2024 році. В окремих закладах цей показник складав 0%. Відсутність результатів якісних та своєчасно виконаних бактеріологічних досліджень суттєво знижує ефективність антибактеріальної терапії та сприяє поширенню збудників з АМР. Несистематичне та недостатнє по кількості виконання мікробіологічних досліджень не дозволяють проводити якісний мікробіологічний моніторинг у ЗОЗ та створювати кумулятивну антибіотикограму передбачену галузевими стандартами. Проведення систематичних навчань з показань та правил відбору біологічного матеріалу для бактеріологічних досліджень – вимоги передбачені стандартом ДСТУ EN ISO 15189, які відсутні у більшості лабораторіях.

Досягнення цільових значень I-III індикаторів неможливо без підвищення потенціалу мікробіологічних лабораторій, роботи клінічних фармацевтів та своєчасного виконання ідентифікації збудників інфекційних хвороб (IV індикатор). Цільові значення 2 стратегічних цілей передбачених у Стратегії для 2024 року не були досягнуті і, враховуючи, великий відрив від значень, є ризик недосягнення їх у 2025 році.

Отримані дані свідчать про таке:

1. Заклади охорони здоров'я явно надлишково (з багатократним перевищенням цільових значень) використовують АМП групи резерву.
2. Співвідношення споживання АМП групи спостереження та доступу вказує на менший, відносно оптимального, рівень вибору останніх.
3. У переважній більшості випадків (~75%) антибактеріальна терапія на спеціалізованому рівні надання медичної допомоги виконується без своєчасного мікробіологічного визначення збудника та його чутливості до АМП.
4. Виявлений рівень споживання АМП різних груп (Ua AWaRe) та своєчасності проведення мікробіологічних досліджень вказує на в цілому низький рівень впровадження принципів раціональної антибіотикотерапії, що може негативно впливати на якість медичної допомоги та знижує ефективність національних заходів протидії поширенню АМР.
5. Заклади охорони здоров'я, що надають первину медичну допомогу демонструють гірший ніж спеціалізована ланка рівень впровадження принципів раціонального використання АМП.

Два цільових значення, які передбачені Стратегією у 2024 році, зокрема рівень використання АМП резерву та своєчасність бактеріологічних досліджень, – не були досягнуті. Для досягнення цільових значень відповідно до Стратегії необхідно:

Для досягнення вищенаведених цільових значень Стратегії відповідальним сторонам **відповідно до Стратегії рекомендуємо наступне:**

1. Забезпечити моніторинг дотримання у ЗОЗ встановлених вимог щодо впровадження програми з адміністрування АМП, стандартів лікування, в тому числі процедур преавторизації антимікробних препаратів групи резерву.
 2. Проводити навчання щодо програми адміністрування антимікробних препаратів, принципів раціонального використання АМП та протидії поширенню збудників з АМР.
 3. Забезпечити акредитацію лабораторій згідно з вимогами стандарту ДСТУ EN ISO 15189. Зокрема, забезпечення лабораторій обладнанням, персоналом та розхідними матеріалами.
 4. Забезпечити навчання персоналу щодо показань та методів відбору біологічного матеріалу для мікробіологічного дослідження.
 5. Впроваджувати у ЗОЗ нові клінічні протоколи щодо діагностики та лікування інфекційних захворювань.
-